

벗어나야 함

- 청소년이 자유롭게 자신의 의견을 표현할 수 있는 환경이 조성되어야 함
- 공동체의 의사결정에 다양한 의견이 자유롭게 소통되면서 합의를 이루어 가는 과정을 경험할 수 있도록 도와야 함

10주차 - 2차시 청소년 섭식장애

1. 청소년 섭식장애의 정의와 실태

1) 섭식장애의 정의와 특징

◆ 섭식장애

- 과도한 식이 요법의 부작용 또는 여러 가지 생리적·정신적 원인으로 인하여 비정상적으로 음식을 섭취하는 증상으로, 특히 여자청소년, 혹은 젊은 여성들에게서 많이 발생하는 정신질환임

◆ 섭식장애의 특징

- 가장 잘 알려진 섭식장애로는 흔히 거식증으로도 알려져 있는 신경성 식욕부진증(Anorexia Nervosa; AN)과 신경성 폭식증(Bulimia Nervosa; BN)이 있음
 - 두 장애 모두 극단적인 섭식행동을 보이고 체중과 몸의 형태를 지나치게 중시하는 특징을 가짐
- 오랫동안 섭식과 관련한 문제적 행동들이 음식물을 섭취하고 흡수하는 것을 변화시켜 신체적, 심리적 건강과 기능에 심각한 손상이 나타남
- 신경성 식욕부진증
 - 신경성 식욕부진증 환자들은 정상체중의 85% 미만 저체중의 신체임에도 불구하고 체중 증가에 대한 극도의 두려움으로 지속적인 음식 섭취 제한 행동을 보이는 것이 특징임
 - 신체에 대한 왜곡된 인식은 신경성 식욕부진증 환자들로 하여금

다이어트를 무리하게 지속하도록 야기함

⇒ 신체 및 심리적 건강에 심각한 부작용을 초래하게 됨

- 신경성 폭식증

- 신경성 폭식증의 경우 단기간 동안(2시간 이내)의 폭식 이후 단식이나 구토 등 체중을 조절하기 위한 보상행동을 반복적으로 보이는 것을 특징으로 함
- *폭식삽화 동안에는 음식물 섭취를 중단 및 통제하거나 조절하는 능력을 상실하게 됨

* 폭식 삽화 : 단위 시간에 일반인의 식사보다 확실히 많은 양을 섭취하며 식사 중 자제가 불가능함

- 폭식장애는 신경성 폭식증과 같이 폭식을 하되 구토나 무리한 운동, 단식 등의 보상행위는 하지 않는 것을 특징으로 함

2) 청소년 섭식장애의 실태와 영향

◆ 청소년 섭식장애의 실태

- 섭식장애는 전체 환자의 30%가 10 - 20대 환자일 정도로, 청소년에게 심각한 정신과 질병임
- 거식증의 평균 발생 연령은 16세, 폭식증과 폭식장애는 18세로 청소년 시기에 발생함
- 섭식장애로 인해 입원외래 치료를 받은 환자의 수는 해마다 꾸준히 증가함
 - 2016년 7,657명 → 2020년 9,463명
- 2020년 기준 성별요양급여총액 비율

남성
20.9%

여성
79.1%

※ 여성이 남성의 4배 수준임

- 연령구간별 요양급여비용총액의 비율
 - 섭식장애 환자들은 대부분 청소년기부터 성인 초기에 집중적으로 분포하고 있음

10-19세	28.8%
20-29세	29.0%
30-39세	14.8%

- 여자청소년은 남자청소년보다 과체중 및 비만 비율이 낮음
BUT, 자신의 체형을 살찐 체형이라고 인지하는 비율이 남자청소년에 비해 높음

⇒ 남자청소년보다 섭식장애로 이어지기도 쉬움

* 2021 보건의료빅데이터개방시스템

◆ 섭식장애의 영향

- 성장이 활발한 청소년 시기 섭식장애를 겪는다면 신체성장과 뇌발달 저하를 가져옴
⇒ 이른 나이에 골다공증을 유발할 수 있음
- 영양부족을 동반하고 뇌신경전달물질의 저하를 초래함
⇒ 신진대사가 줄어들고 장기가 제 기능을 하지 못해 극단적인 경우 사망까지 이를 수 있음
- 여성은 무월경이 나타나 난임으로 이어질 수 있음
- 정서, 감정 기능에도 문제가 생겨 가족이나 직장, 학업 등의 모든 일상생활과 인간관계에 어려움을 가져오고, 우울증에 빠지기 쉬움
- 거식증의 치사율은 5% 정도로, 정신질환 중 치사율이 가장 높음
- 과도한 음식 섭취 제한은 정신 · 신체에 장 · 단기적 위험을 초래함
 - 단기적 → 주의집중을 어렵게 만들고 피로감이나 두통을 야기할 수 있음
 - 장기적 → 영양 불균형을 초래하고, 빈혈 및 탈수증상 등이 나타날 수 있음
- 식사 후 구토를 하거나 이뇨제를 복용하는 등의 보상행동은 신체에 여러 가지 심각한 문제들을 유발할 수 있음
(예) · 치아와 식도를 손상시킴
· 위장 장애를 일으킴
- 심각한 우울과 불안, 강박, 약물남용 등의 여타 정신질환과 동반될 가능성이 매우 높음
- 극단적인 경우에는 자살의 위험에까지 이르게 됨

2. 청소년 섭식장애의 원인

1) 심리적 요인

◆ 청소년 섭식장애의 심리적 요인

- 낮은 자존감과 부정적인 자아상이 섭식장애의 원인이 됨
- 사춘기 때 일어나는 신체적 변화에 대한 심리적 반응은 특별히 그들의 체중에 대한 지각과 만족도에 영향을 줌
- 청소년들의 30%는 그들이 사회에서 강조하는 이상적인 신체기준보다 살이 찼다고 생각함
 - 남녀 모두에게 공통된 것이기는 하지만, 여자 청소년들의 경우 조금 더 심각한 편임
- 여자 청소년은 자신의 체중이 정상보다 약간 적다고 생각될 때 가장 만족하는 경향을 보임
- 자신의 몸무게가 정상보다 많이 나간다고 여기는 여자 청소년은 자신에 대해 부정적인 이미지를 가지는 것으로 나타남

◆ Freud의 정신분석학에서의 신경성 식욕부진

- 신체적 성숙과 성에 대한 책임감에 대한 두려움과 관련이 있다고 봄
- 자신의 신체와 성뿐만 아니라 성격과 사회적 기술에도 특별히 부정적 태도를 가짐
- 완벽주의로 인해 자신의 왜곡된 신체 이미지에 대해 불만족하는 경우가 많음

2) 대인관계 요인

◆ 청소년 섭식장애의 대인관계 요인

- 신체에 대한 청소년들의 반응은 또래청소년에 의해서 청소년들에게 전달된 기준과 기대를 반영함
- 한 연구에서는 학교에서 가장 부러운 친구로 ‘외모가 뛰어난 친구’가 선정됨
 - 학업에 뛰어난 친구나 교우 관계가 좋은 친구보다 우위에 있을 정도로

- 외모에 대한 관심이 얼마나 많은지 알 수 있음
- 한국 청소년의 경우 자신의 신체 및 용모에 대한 만족도는 매우 떨어지는 편임
 - 남학생보다 여학생이 신체에 대한 불만이 높음

3) 사회문화적 요인

- ◆ 청소년 섭식장애의 사회문화적 요인
 - 대중매체를 통해 접하는 아이돌의 경우 비정상적으로 말랐음에도 지속적으로 극단적인 다이어트를 하는 모습을 보임
 - ⇒ 사회적 미의 기준과 가치관도 변화하고 있음을 알 수 있음

3. 청소년 섭식장애의 보호방안

1) 전문가 개입

- ◆ 섭식장애의 치료
 - 주로 약물치료보다는 심리치료를 통해 개입이 이루어지고 있음
 - 현재까지 섭식장애의 치료만을 위해 공식적으로 허가된 약물이 없기 때문임
 - 섭식장애는 우울, 불안, 분노와 같이 다양한 부정적 정서를 동반하는 경우가 많음
 - 특히 우울장애는 섭식장애 환자들이 함께 진단받는 경우가 많은 질환임
 - 섭식장애의 치료 또한 환자들의 이러한 심리적 특성을 고려하여 이루어지고 있음
 - 현재까지 효과성이 검증된 치료적 방안은 인지행동치료가 있음
 - 섭식장애 환자의 정신병리적 특성과 심리적 증상, 우울감 등을 감소시킴
 - 체중 및 체형에 대한 염려, 불안 등을 중재하는 효과가 장기적으로 유지된다는 장점이 있음
 - 섭식장애를 위한 약물치료로는 주로 항우울제, 항구토제, 항경련제 등이 사용되고 있음

- 부모의 기능적인 양육태도나 안정적인 부모와의 애착관계는 섭식장애에서 보호요인으로 작용함
⇒ 가족구성원과 함께하는 치료가 효과적임
- 특히, 거식증의 경우 성공적인 치료는 가족치료임
 - 구조적 가족치료가 가장 성공적인 형태의 치료라고 알려져 있음

2) 미디어 교육의 필요성

◆ 청소년의 올바른 교육방안

- 사회적으로 마르고 날씬한 몸매를 선호함
⇒ 미의 기준이 되는 경향이 있음
- 청소년의 경우 유행에 민감하고 정보를 무분별하게 흡수하는 경향이 있어 왜곡된 미의식이 형성되어 부정적인 자아상을 가지게 됨
- 미디어의 함정에 빠지지 않도록 경계하고, 올바른 방법으로 미디어를 소비하는 능력을 교육해야 함
- 섭식장애의 위험성을 인식하고 섭식장애에 빠지지 않게 교육해야 함